

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	肝母細胞瘤 Hepatoblastoma				
編號	A31000-Q03-W-N27	制定者	R11 吳淑鈞	公布日期	112 年 02 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 02 月 07 日
版本/總頁數	第 1.0 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

護理人員能瞭解肝母細胞瘤的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，增加臨床照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部兒科單位。

三、說明

（一）定義

肝母細胞瘤是一種罕見的腫瘤，兒童中最常見的原發性肝惡性腫瘤，發生在 5 歲以下的兒童，發病的平均年齡為一歲八個月，男與女的發病率約為 1.5：1。

（二）成因

肝母細胞瘤的發病機制尚未完全確定原因，一般認為是胚胎性腫瘤之一。

（三）症狀

發病初期症狀不明顯，通常是腫瘤變得很大的時候，才會出現症狀。症狀如：

1. 腹部腫塊和腹痛、噁心或嘔吐。
2. 腹脹。
3. 發燒。
4. 呼吸困難：腫瘤壓迫橫膈膜而致。
5. 黃疸、膽紅素增高。
6. 靜脈曲張、出血、腹水：腫瘤壓迫、阻塞肝門靜脈所致。
7. 貧血、容易出血：因肝功能異常所致。

主題名稱	肝母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N27	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/7

8. 皮膚癢。
9. 體重減輕、食慾差、腹瀉。
10. 背痛：腫瘤壓迫所致。
11. 大腫瘤可能併發破裂和出血。

（四）診斷與檢查

詢問病史及身體檢查，抽血檢查，影像學檢查，腫瘤組織切片檢查，以診斷及確認侵犯範圍。

1. 抽血檢查：α 胎兒蛋白（Alpha-fetoprotein, AFP），血球計數檢查、生化檢查、肝腎功能、基因檢查等。
2. 影像學檢查：超音波、骨骼掃描、電腦斷層掃描、磁共振造影。

（五）分類

分期系統由國際肝臟腫瘤研究群所制定的 PRETEXT 分期，依據影像上肝臟血管的解剖位置，來判斷腫瘤在肝臟內的侵犯程度。PRETEXT- I：腫瘤侵犯四分之一肝臟；PRETEXT- II：腫瘤侵犯相鄰四分之二肝臟，另外四分之二肝臟沒有受到侵犯；PRETEXT- III：腫瘤侵犯相鄰的四分之三肝臟，或是二個不相鄰四分之一肝臟；PRETEXT- IV：腫瘤侵犯四分之四肝臟。

（六）治療

治療方式分為：

1. 手術治療：初期診斷腫瘤太大若無法切除，先做切片得到正確病理診斷，之後化學治療使腫瘤縮小再進行手術切除，有些需要做兩次以上的手術才能將腫瘤切除。手術後還需要化學治療。
2. 化學治療：常用的化療組合：
 - (1) Cisplatin、Epirubicin
 - (2) Carboplatin、Etoposide
 - (3) Vincristine、Carboplatin、5-FU
 - (4) Vincristine、Cyclophosphamide、5-FU 等

主題名稱	肝母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N27	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/7

3. 放射治療：放射線是使腫瘤縮小，以利手術切除。

4. 肝臟移植。

(七) 護理問題

1. 易感染/與白血球下降、手術傷口、放射線及化學治療有關。

2. 口腔黏膜異常/與化學藥物治療造成黏膜缺損有關。

3. 缺乏營養/與食慾不振、噁心、嘔吐有關。

4. 身體心像不一致/與化學藥物治療導致頭髮脫落有關。

5. 易受傷害/血小板下降有關。

6. 活動耐力不足/紅血球下降有關。

7. 疼痛不適/與手術有關。

8. 健康保護能力不足/與對疾病治療之知識缺乏有關。

(八) 護理措施

1. 易感染/與白血球下降、手術傷口、放射線及化學治療有關。

(1) 保護皮膚及黏膜之完整性，監測生命徵象。

(2) 教導病人與家屬訪客注意事項，如：在接近病人之前先洗手。

(3) 視需要限制訪客，減少病人的暴露及預防感染。

(4) 當白血球下降，抵抗力變弱時，給予保護性隔離。

(5) 教導病人及家屬感染的症狀與徵象，傷口遵守無菌技術換藥，觀察有無發燒、傷口紅腫、化膿等感染現象。

(6) 做化學治療或是放射線治療時，評估口腔黏膜破損情形，協助執行口腔護理。

(7) 教導免疫抑制的病人不可接種活性病毒疫苗，不可以和患水痘或麻疹的人接觸。

2. 口腔黏膜異常/與化學藥物治療造成黏膜缺損有關。

(1) 注意口腔黏膜狀況，選擇質地柔軟的牙刷或軟綿棒，清潔口腔，避免出血。

(2) 若有口腔破損，應避免進食過熱或酸性食物。

主題名稱	肝母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N27	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/7

(3) 依醫囑給予局部麻醉劑止痛，減少疼痛。

(4) 依醫囑給予 Mycostatin 漱口水減輕不適及異味，預防口腔黴菌感染。

3. 缺乏營養/與食慾不振、噁心、嘔吐有關。

(1) 每日量體重、評估病人進食情形。

(2) 收集病人喜好的食物，設計納入餐飲計畫中。

(3) 鼓勵進食高蛋白、高熱量的飲食。

(4) 少量多餐進食。

(5) 避免過熱或刺激性食物，給予較柔軟食物。

(6) 依醫囑給予止吐劑使用。

4. 身體心像不一致/與化學藥物治療導致頭髮脫落有關。

(1) 先向病人及家屬說明落髮是藥物導致，給予心理準備。

(2) 使病人及家屬了解落髮非永久性，停止治療後，頭髮會再生（若是高劑量放射線治療，頭髮也許可能永不再生）。

(3) 告知病人及家屬，毛髮脫落的現象可能為全身性的。

(4) 如為長髮可以先將頭髮剪短，減輕落髮時的衝擊。

(5) 介紹可以戴假髮或是合宜的帽飾，運用遊戲治療，鼓勵病人說出落髮的感受，介紹病友認識。

5. 易受傷害/血小板下降有關。

(1) 避免費力的活動，避免受傷，預防造成出血。

(2) 避免進食粗糙或堅硬的食物，以防口腔黏膜受損。

(3) 觀察出血的症狀，如：皮膚、尿液、糞便等，有無顱內出血徵象（頭痛、複視、噴射式嘔吐）。

(4) 減少不必要的皮膚穿刺。

(5) 預防意外傷害發生。

6. 活動耐力不足/紅血球下降有關。

(1) 給予足夠的休息。

主題名稱	肝母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N27	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/7

(2) 採集中護理。

(3) 評估病人活動體力程度，設計適合病人的活動，以達到休息的目的又防止退縮，如繪畫、說故事、閱讀、下棋等。

(4) 安排年齡相仿、興趣相同，和同樣需要限制活動的室友。

7. 疼痛不適/與手術有關。

(1) 評估疼痛的特徵，如：疼痛的性質、部位、持續的時間、疼痛指數等。

(2) 監測並記錄生命徵象。

(3) 提供舒適的臥位及安靜的環境。

(4) 使用疼痛控制法，如：分散注意力、鬆弛技巧..等，以減輕不適。

(5) 必要時依醫囑給予止痛劑並監測其副作用。

8. 健康保護能力不足/與對疾病治療之知識缺乏有關。

(1) 出院前，評估病人及家屬對有關的病因及治療之了解程度，給予適當教導。

(2) 提供家屬資料和照顧的方法，以便病人返家的照顧。

(3) 教導必需回醫院接受診查的症狀，如:發燒、臉色蒼白、瘀斑等。

(4) 教導有關治療所造成的長期影響。

(5) 告知定期返診醫院的時間。

(九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

主題名稱	肝母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N27	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/7

(一) 中華民國兒童癌症基金會 (2022, 4 月 05 日)・兒童肝腫瘤。

<https://ccfroc.org.tw/node/151>

(二) 曾翠華、梁淑華、林美華、吳書雅、王冠今、曾紀瑩、劉千琪、廖愛華、吳維紋、李慈音、陳月枝(2017)・癌症兒童的護理・於陳月枝總校閱，實用兒科護理(八版，941-1005 頁)，華杏。

(三) 劉英妹(2020)・兒童血液疾病與護理・於黃美智、蔣立琦總校閱，兒科護理學(最新修訂版，9-01-9-55 頁)，永大。

(四) Malogolowkin , M. (2022) . Overview of hepatoblastoma . Up ToDate . Retrieved July 23 , 2022 , from [https://www.uptodate.com/contents/overview-of-hepatoblastoma? search= Hepatoblastoma&source= search_result&selectedTitle=1~41&usage_type= default&display_rank=1](https://www.uptodate.com/contents/overview-of-hepatoblastoma?search=Hepatoblastoma&source=search_result&selectedTitle=1~41&usage_type=default&display_rank=1)

七、附件

(略)

